老年人健康生活实用教材

健康知识，简单学 · 天天用



SUSTech-BIO出品

目录

第一章 认识我们的身体……3

第二章 常见慢性病管理……9

第三章 合理用药与保健品……15

第四章 科学饮食……21

第五章 安全运动与康复……27

第六章 日常生活安全……33

第七章 心理健康与社交……39

第八章 定期体检与就医指南……45

阅读说明：

本教材用通俗语言介绍常见健康问题。疾病诊断、用药和治疗目标因人而异。文中涉及个人治疗的内容，请遵医嘱。遇到急症，**请拨打 120**。

第一章 认识我们的身体——衰老的正常变化与异常信号



第 1 章导图：认识身体的四个重点

1.1 身体变慢，不等于生病

人上了年纪，身体像一辆开久了的车。启动慢一点，常常是自然变化。看近处费劲、头发变白、皮肤变干，都很常见。走路速度慢些，肌肉力量少些，也可能是衰老的一部分。

记忆偶尔卡壳，不一定是痴呆。比如一时想不起熟人名字，过一会儿又想起来。钥匙放错地方后来找得到也常见。关键要看变化是否持续加重。

正常变化通常比较缓慢。它不会一下子让人失去原有生活能力。可以留意自己半年或一年来的变化。若总是越来越差，或影响吃饭、穿衣、出门，就适合就医评估。

别把所有不舒服都归为“年纪大了”。胸闷、跌倒、明显消瘦、持续疼痛，都值得认真看待。早发现，往往更容易处理。



图 1-1 老年人参加社区活动。

1.2 哪些变化可以观察，哪些要就医

视力逐渐模糊，可能与老花或白内障有关。**听力慢慢下降**，也很常见。可以请医生检查眼睛和耳朵。不要只靠放大音量解决听力问题。

睡眠时间变短，有些老人会遇到。白天仍有精神，生活不受影响时，可以先调整作息。若**连续失眠，情绪低落，或白天频繁打瞌睡**，可以向医生说明。

胃口变小不一定有大问题。但**体重持续下降、吞咽困难、反复呕吐**，需要查原因。**排便习惯突然改变，或大便带血**，也要尽快就医。

以下情况别等一等：突然胸痛或胸闷，突然一侧手脚无力，突然说话不清，突然严重气喘，突然意识不清。请马上拨打急救电话。

1.3 记好自己的健康底账

健康底账像家里的账本。它能帮助医生看清变化。**建议准备一张纸，记下疾病、药物、过敏和手术史。每次看病都带上。**也可以记录**血压、血糖、体重和症状。记录时写日期、时间和当时情况。**比如饭前还是饭后，是否刚走过路。单个数字不如长期趋势有用。

家人可以一起整理紧急联系人。把常用药放在固定位置。药盒标签要清楚，别把不同药片混在一起。

如果听不清医生的话，可以请医生慢一点说。也可以带一位信任的人陪诊。离开诊室前，复述一遍药怎么吃、何时复诊。

1.4 体力和记忆变化的自我观察

可以用日常小事观察**体力**。过去能轻松上楼，现在是否常要停下来？从椅子起身是否变困难？近几个月是否跌倒或差点跌倒？这些变化可以告诉医生。

记忆也可观察生活能力。是否常忘记关火、忘记吃药？是否在熟悉的地方迷路？是否重复问同一件事？若影响安全和独立生活，建议尽早评估。

体力下降有时与营养不足、贫血、心肺问题或药物有关。记忆变差也可能与睡眠、情绪、听力或药物有关。查清原因比自行猜测更可靠。

家人观察时，尽量讲具体例子。不要只说“最近糊涂”。可以说“这个月三次忘记关燃气”。医生更容易据此判断。

如果老人一个人生活，可以把**急救电话、家属电话和常见病写在纸上，贴在显眼处**。家人可定期确认手机能联系上。身体变化越早说清楚，越容易找到合适帮助。

和医生沟通时，可以使用“我以前怎样，现在怎样”的说法。比如“以前能走到菜场，现在走到楼下就要停”。这种描述比只说“没力气”更具体。如果某个变化只在特定时候出现，也要说

明情境。比如“吃完药后站起来会晕”或“晚上关灯后看不清”。这能帮助医生判断原因。

身体出现变化时，家人尽量先听本人讲完。不要马上说“你就是老了”。观察、记录、就医，是更稳妥的三步。家人可以用温和的方式确认变化。先问“最近做这些事有没有更费劲”，再问“你希望我帮哪一部分”。不要因为一次忘事就下结论，也不要忽略反复出现的困难。

睡眠、心情、疼痛和听力都会影响日常表现。就医时把这些情况一并说出。医生可能先处理可改善的问题，再安排进一步检查。

若老人不愿马上就医，可以先约一次家庭医生或社区门诊。由熟悉情况的医护人员解释检查目的，往往更容易建立信任。

本章小结

- 年龄增长会让身体慢下来，但突然或持续加重的变化要重视。
- 记住自己的日常状态，才容易发现异常。
- 突然胸痛、偏瘫、说话不清，立即拨打急救电话。
- 带上疾病和用药清单就医。

☑ 自测题

1. 哪种变化更需要尽快就医？

A. 头发变白　B. 突然一侧手脚无力　C. 偶尔忘记名字

2. 体重记录有什么用？

A. 看长期变化　B. 代替医生诊断　C. 可以停药

答案：1. B　2. A

♥ 生活小贴士

- 今天记录一次自己平常的血压或体重。
- 把紧急联系人写在手机旁。

第二章 常见慢性病管理——高血压、糖尿病、冠心病、脑卒中、骨质疏松、关节炎



第 2 章导图：慢病管理的四个重点

2.1 高血压和糖尿病：盯住长期趋势

高血压常常没有明显感觉。它像水管里的压力长期偏高，慢慢伤害心、脑和肾。按中国现行指南，未服降压药时，诊室血压在不同日多次达到或超过 **140/90 毫米汞柱**，需由医生判断是否为高血压。

家中测量时，先坐着安静休息约 5 分钟。袖带大小要合适，手臂放在桌面。每次测两遍，间隔约 1 分钟，并记下数值。不要因为一次正常就停药。

糖尿病是血液里的糖长期偏高。诊断要由医生结合检查判断。常用检查包括空腹血糖、餐后血糖和糖化血红蛋白。糖化血红蛋白可以反映近几个月的平均血糖。

老年人的血糖目标因身体状况而异。体弱、常低血糖或有多种疾病的人，目标可能更宽。具体目标请遵医嘱。**手抖、出汗、心慌、发软，可能是低血糖信号**。



图 2-1 医护人员为居民测量血压。

2.2 冠心病和脑卒中：认出急症信号

冠心病是给心脏供血的血管变窄。活动时胸口压迫、发闷或疼痛，休息后缓解，值得就医检查。若胸痛持续不退，伴冷汗、恶心或气短，要马上呼叫急救。

脑卒中就是脑血管突然堵住或破裂。记住“看、抬、说、打”：看一侧脸是否歪；抬双手看是否一侧下垂；说一句话看是否含糊；发现异常就打 120。记下症状开始时间。

不要给疑似脑卒中者喂水、喂药或食物。也不要自行开车长途送医。尽量让患者平躺或侧卧，保持呼吸通畅，等待急救人员。脑卒中后突然出现的新无力、新口齿不清，也按急症处理。不要因为症状一会儿减轻就忽略。

2.3 骨质疏松和关节炎：保护骨头与关节

骨质疏松会让骨头变脆。轻轻一摔也可能骨折。身高变矮、驼背或腰背痛，可能提示问题。是否需要骨密度检查，请和医生商量。

骨头需要钙、维生素、适当活动和日照。可以从**奶类、豆制品和深绿色蔬菜**中获得钙。补充剂是否需要、用多少，请遵医嘱。肾结石或肾病患者尤其要先咨询。

关节炎会带来关节疼痛、僵硬或活动不便。晨起僵硬常见于某些关节病。热敷或轻柔活动可能帮助部分人，但红肿发热、突然剧痛，应就医。

不要长期自行吃止痛药。部分止痛药会伤胃、肾或影响血压。关节疼痛持续时，请医生选择合适办法。

2.4 把慢病管理放进每天生活

慢性病管理像每天照料一盆花。吃药、饮食、活动和复查都要一点点坚持。把服药时间和日常活动连起来，比较容易记住。比如刷牙后看药盒。

饮食上少盐、少油、少含糖饮料。每餐有蔬菜，主食不过量。运动从舒服的速度开始。感觉胸痛、明显气喘或头晕，要停下来休息。

按时复诊，带上家庭记录。别只看某一次化验值。把指标变化和身体感受一起告诉医生。医生可能需要根据肾功能、年龄和其他药物调整方案。

不要照搬邻居的药。两个人病名相同，身体状况也可能不同。保健品也不能替代降压、降糖或抗栓治疗。

慢病患者可把目标拆成小步骤。先做到按时复诊，再慢慢调整饮食和活动。不要一天之内同时改变很多习惯。身体会更容易适应，也方便观察哪项改变有帮助。

例如，李阿姨测血压时总忘记记数。她把记录本放在血压计旁边，每次测完立刻写下。两周后，她和医生一起看趋势，再决定是否调整治疗。

如果同时有高血压、糖尿病和关节痛，就诊时把问题一起告诉医生。医生会考虑药物之间的影响。症状突然变化时，不要等下次常规复诊。

家庭记录要保持简单，才容易坚持。血压计旁放纸笔，血糖仪旁放记录表。每周选一天回顾一次。如果数字反复偏高或偏低，联系医生确认，不要自行改变药量。

测血压时，尽量使用经过验证的上臂式血压计。测量前排空膀胱，背部有支撑，双脚平放地面。袖带不要隔着厚衣服。手臂与心脏大致同高。

测血糖前后按仪器说明清洁双手。记录测量时间和进餐关系。不同时间测出的结果不能简单互相比。遇到不确定的数字，把仪器带去门诊请教。

家庭血压测量尽量固定在相近时段。不要边聊天边测，也不要在刚喝浓茶、抽烟或运动后马上测。把连续多天的数据带给医生。测量目标由医生根据年龄和身体状况商定。

降压药种类很多，作用方式也不同。有些药会影响心率、脚踝或咳嗽。发生不适时记下药名和症状，再联系医生。不要因一次头晕就长期停药。

糖尿病患者可以按医生建议检查眼底、肾功能、足部和心血管风险。脚上有水泡或伤口时，不要自行剪除。及时处理小伤口，避免发展成严重感染。

本章小结

- 血压和血糖看长期记录，不只看一次。
- 胸痛不退、突然偏瘫或说话不清，马上求助。
- 骨头和关节要保护，止痛药别长期自用。
- 慢病目标因人而异，请遵医嘱。

自测题

1. 家测血压前，建议先安静坐多久？

A. 约 5 分钟　B. 立刻测　C. 快走后测

2. 怀疑脑卒中时，哪种做法合适？

A. 喂水　B. 等症状消失　C. 打 120 并记下发病时间

答案：1. A　2. C

生活小贴士

- 连续一周记录血压或血糖。
- 把慢病药物清单放进就诊包。

第三章 合理用药与保健品——处方药怎么吃、保健品怎么选、常见骗局识别



第 3 章导图：用药与保健品的四个重点

3.1 把药吃对：时间、剂量和疗程

药物像工具，用对能帮忙，用错会添麻烦。处方药按医生交代服用。别自行加量、减量或停药。即使感觉好转，也先问医生。

看药袋上的**姓名、药名、每次用量和时间**。饭前、饭后或睡前，意思不同。若标签看不清，可以请药师重新说明。不要凭颜色认药。漏服一次时，不要随手加倍补上。不同药的处理办法不同。可以查看说明或联系医生、药师。服药后若出现皮疹、呼吸困难、严重头晕，要及时求助。

老年人常同时吃几种药。每次就诊都带上全部药物清单。包括**处方药、非处方药、中药和保健食品**。医生和药师可以检查重复和相互影响。



图 3-1 老人向药师核对处方药。

3.2 多种药一起吃：先核对再调整

两种药一起用，效果可能增强，也可能互相影响。酒、柚子、补品也可能影响某些药。每种药的注意事项不同，不能套用同一条规则。

建议把药分成“每天吃”“需要时吃”“已经停用”三栏。更新清单时写清日期。过期药、来源不明的药，不要继续服用。不

要把药片掰开或磨碎，除非医生或药师确认可以。缓释片、肠溶片等药物可能不能随意处理。吞咽困难时，可以请医生换剂型。

服药后觉得乏力、跌倒、便秘或意识模糊，可能与药物有关。记录发生时间和用药变化咨询医生。请勿擅自停掉重要药物。

3.3 药品和保健食品不是一回事

药品经过审批，用于预防、诊断或治疗疾病。保健食品主要用于补充营养或调节身体状态。它不能代替治疗疾病的药物。

看包装时留意**“蓝帽子”标志和批准信息**。保健食品不能宣称治愈高血压、糖尿病或癌症。若销售者说“包治百病”，要提高警惕。

补钙、鱼油、维生素等是否适合，要看饮食、检查和疾病情况。补得太多也可能有害。正在服抗凝药、降糖药或有肝肾病时，更要先咨询。

不要因为广告里有医生形象就相信。真正的诊疗需要看本人情况。正规医生不会要求您停止原有处方药，改吃某种保健品。

3.4 识别“神药”和保健品骗局

常见话术有**“祖传秘方”“三天见效”“不用看医生”“名额只剩几个”**。还有人假扮专家，先免费讲座，再高价卖产品。

遇到推销，先不付款、不签字、不交身份证和银行卡。把产品名称拍下来，回家和家人商量。需要时向正规医疗机构或药师核对。保留发票、聊天记录和包装。发现虚假宣传，可以向市场监管部门反映。遇到冒充公检法或要求转账的电话，挂断后拨打官方电话核实。

真正可靠的健康建议不会催您马上掏钱。治疗方案应有清楚诊断和风险说明。对陌生人提供的药，别试吃。

可以请药师做一次“家庭药物核对”。把所有药盒、药袋和补充剂带去。药师能帮忙确认药名、服用时间和重复成分。核对后，把旧清单划掉，换上新日期。

例如，张伯伯从医院和诊所各拿了一种止痛药。他以为包装不同就不是同类。药师核对后发现用途相似，提醒他先问医生再服。这样能减少重复用药的风险。

家里不要用别人的处方药。不要把药分给邻居。若药片外观变化、包装破损或储存不当，先咨询药师。药放在固定位置，也要避开潮湿和高温。

处方药要从正规医疗机构或药店获得。包装上的通用名称和批准信息要清楚。不要购买散装药或来路不明的“特效药”。网购药品也要确认平台和经营资质。

家人帮忙整理药物时，最好由本人参与。逐个核对用途，确认哪种药已经停用。不要把医生曾经开的旧药当成现在的方案。复诊时问清楚是否继续。

如果需要长期服药，可使用有日期和时段的分格药盒。但每次装药前要对照最新清单。不同药物保存要求可能不同，不能全部倒进一个盒子长期存放。

用药安排可以放在一张大字表上。用“早餐后”“晚饭前”等生活提示，比只写数字更容易记。药物改变后及时更新，旧表收起来，避免家人照旧表配药。

药物保存要看说明。有的需要避光，有的不能放在潮湿浴室。药瓶盖要盖紧。冰箱保存的药也要避免冷冻。外包装和说明书先留好，出现疑问时方便核对。

购买保健食品前，先问自己三个问题：我为什么需要它？有没有和药物冲突？谁能为宣传内容负责？如果销售者无法说清，就先不买。

本章小结

- 药按医嘱吃，停药前先问医生。
- 看不懂标签，就问药师。
- 保健食品不能治病，也不能代替药品。
- 遇到催付款、包治病，先停下来核实。

自测题

1. 保健食品能替代降压药吗？ A.能 B.不能 C.看广告

2. 漏服一剂药，较稳妥的做法是什么？ A.下次加倍 B.先核对说明并咨询 C.永远停药

答案：1.B 2.B

生活小贴士

- 把正在吃的药和保健品列成清单。
- 下次买补品前先咨询医生或药师。

第四章 科学饮食——一日三餐怎么搭、特殊疾病饮食禁忌、喝水



第 4 章导图：科学饮食的四个重点

4.1 一日三餐：每餐搭配几类食物

吃饭像搭积木。主食、蔬菜、蛋白质食物都要有。主食可以有米饭、面、杂粮。蛋白质可选鱼、蛋、奶、豆制品或瘦肉。

盘子里可以让蔬菜占较大位置。主食和肉类适量搭配。牙口不好时，把菜切碎、炖软。若体重下降或吃得少，可以少量多餐。

早餐可有主食、鸡蛋或豆制品，再配奶和蔬果。午餐和晚餐尽量有蔬菜及优质蛋白。点心可选酸奶、水果或少量坚果。

不必追求昂贵食材。豆腐、鸡蛋、时令蔬菜也能搭出营养。每周换着吃，颜色和种类多一些。



图 4-1 多种蔬果搭配。饮食份量请结合个人情况调整。

4.2 高血压、糖尿病和肾病的饮食

高血压患者可以少吃咸菜、腌肉、方便食品和重口味酱料。盐不只在盐罐里，也藏在加工食品中。少放一点盐，逐步适应清淡口味。

糖尿病不等于完全不吃主食。主食份量要稳定，优先选择全谷物和杂豆。甜饮料、糕点和大量精制糖尽量少。药物和饮食要配合，别突然不吃饭。

冠心病患者可以减少肥肉、动物油和油炸食物。多选鱼、豆类、蔬菜和适量坚果。是否需要限制某种食物，要结合血脂和医生建议。

肾功能不好的人，钾、磷、盐和水分可能需要调整。不同肾病阶段要求不同。不要自行大量喝汤或补充蛋白粉，请遵医嘱。

4.3 喝水：少量多次，个体调整

老人不一定容易感觉口渴。可以把水杯放在看得见的地方。每次喝几口，分散在一天里。温和气候、活动不多时，成人饮水参考量约为**男性 1700 毫升、女性 1500 毫升**。

这个数值不是人人相同。天气热、出汗多时可能需要增加。心衰、肾病或医生要求限水的人，要按医嘱控制。水、茶、汤和食物中的水分都要考虑。

尿色偏深可能提示喝水少，但也会受药物和疾病影响。不要只靠尿色判断。若尿量明显减少、持续口干或头晕，可以联系医生。

夜间尿频的人，可以把较多饮水安排在白天。不要为了少上厕所而整天不喝水。吞咽困难者需让专业人员评估饮水方式。

4.4 食欲差、吞咽困难和食物安全

食欲变差时，先看口腔、牙齿和药物影响。饭菜可以做得软一些、香一些。每餐量少些，间隔时补充营养。持续吃不下或体重下降，要就医。

喝水总呛咳、吃饭声音变湿，可能有吞咽问题。不要强行喂饭。让医生或康复治疗师评估，确定合适的食物软硬和稠度。

剩饭要及时冷藏，再吃前彻底加热。生熟食物分开处理。肉蛋要煮熟。老人免疫力可能较弱，变质食物不要舍不得扔。

保健滋补品不是越多越好。食品补充不能替代正规诊治。过敏、肝肾病或需要控制体重的人，饮食调整请咨询医生或营养师。

买菜时可以先列一张清单。每周安排几次鱼、蛋、豆制品和奶类。蔬菜选不同颜色，水果选完整新鲜的。预算有限时，豆腐、鸡蛋和当季蔬菜也很实用。

例如，早餐吃粥时，可加一个鸡蛋和一份青菜。午餐用杂粮饭配豆腐和鱼。晚餐做软烂的蔬菜和瘦肉。牙口不好可以切碎、炖软，不必只喝粥。

吃饭速度放慢，认真咀嚼。独自吃饭时也尽量坐在桌边。若经常剩饭，可先盛小份，吃完再添。食量突然减少、衣服变松或常呛咳，都要告诉家人或医生。

一周菜单不需要复杂。可以按“主食加蔬菜加蛋白质”来检查。每顿饭问自己：有菜吗？有豆、蛋、奶、鱼或肉吗？主食量是否适合自己？这样比追逐单一超级食物更实在。

身体发热、腹泻或出汗很多时，水和食物需要调整。若有心衰、肾病或医生规定限水，不要自行大量补水。出现明显脱水、虚弱或持续呕吐，应及时求医。

吞咽或咀嚼困难者，可把食物切小、煮软，必要时请专业人员建议稠度。不要边走边吃，也不要躺着进食。进餐时坐直，吃完后保持坐姿一会儿。

不要只看体重决定是否营养够。肌肉明显变少、走路变慢，也值得关注。每周称重一次即可，尽量使用同一台秤、相近时间。体重变化明显时向医生说明。

有高血脂的人不必把所有油脂都戒掉。烹饪可少油，选蒸、煮、炖或凉拌。具体脂肪摄入要结合疾病和化验结果。不要用所谓排毒茶替代正常饮食。

饮食禁忌要有依据。痛风、肾病、心衰和糖尿病的要求不同。网上流传的统一食谱不一定适合每个人。把问题带给医生或营养师，逐项确认。

本章小结

- 每餐有主食、蔬菜和蛋白质食物。
- 控盐、控糖要看总量，不靠单一偏方。
- 饮水少量多次，心肾疾病者先问医生。
- 吞咽常呛咳或体重下降，及时就医。

☑ 自测题

1. 一般成人饮水参考量是？ A.男女完全一样 B.男性约 1700 毫升、女性约 1500 毫升 C.人人固定 3000 毫升

2. 糖尿病是否要完全不吃主食？ A.要 B.不要，需控制搭配 C.只吃水果

答案：1.B 2.B

♥ 生活小贴士

- 下一餐加上一种蔬菜和一种蛋白质食物。
- 准备一个水杯，白天分次饮水。

第五章 安全运动与康复——适合老年人的运动、跌倒预防、术后和病后康复



第 5 章导图：运动与康复的四个重点

5.1 选适合自己的活动

运动像给身体做保养。散步、太极、骑固定自行车、坐姿抬腿，都可以成为选择。先从轻松的活动开始。能边走边说话，通常强度较合适。

一般健康成年人可逐步增加活动量。目标可参考每周累计 150 分钟中等强度活动，再配合力量和平衡练习。体弱或有慢病者要从更少开始。具体安排请遵医嘱。

运动前穿合脚鞋，带上助行器或拐杖。天气太热或太冷时，改在室内活动。饭后不要马上剧烈运动。

胸痛、心慌、头晕、气喘明显时，马上停下。坐下或躺下休息。症状不缓解，及时求助。不要硬撑着完成计划。



图 5-1 老人在户外步行。运动强度请量力而行。

5.2 练力量和平衡，减少跌倒

腿有力，站得稳，跌倒机会会少些。可以扶着稳固桌面练习坐站。坐在椅子上，双脚踩稳，再慢慢站起。开始时旁边有人看护。

走直线、脚跟接脚尖等平衡动作有一定难度。身体不稳的人先不要独自尝试。可以在康复人员指导下练。

运动场地要干燥、明亮。地毯边角压平。不要穿拖鞋或袜子在光滑地面走。夜里起床先开灯，坐一会儿再站起来。

若使用拐杖或助行器，要调到合适高度。器具损坏时及时维修。视力和听力有问题，也要安排检查。

5.3 生病或手术后的康复

康复不是越快越好，而是一步一步恢复。出院时请问清楚：伤口如何护理，哪些动作暂时避免，何时复诊。把医生给的计划带回家。

术后活动要遵医嘱。有人需要尽早下床，有人需要暂时保护关节或伤口。不要照搬别人经验。家人协助时，先听专业人员示范。

脑卒中后可能需要练习走路、说话和吞咽。越早进行合适的康复，越有机会恢复功能。训练要安全，避免拉扯患侧手臂。

疼痛突然加重、伤口发红流脓、发热、呼吸困难或小腿明显肿痛，应及时联系医院。康复过程中记录每天能做的事，鼓励进步，也留意疲劳。

5.4 运动计划怎样坚持

把运动放进固定时段，更容易坚持。比如早餐后散步十分钟。天气不好时，在家做坐姿动作。短时间活动也有价值。

可以用日历打勾，记录活动时间和身体感受。每周看看是否逐渐增加。若第二天疼痛明显或很疲劳，可以减少强度。

运动不是比赛。朋友走得快，不代表自己也要跟上。以安全和舒服为准。运动时有人陪伴，尤其是刚开始或曾跌倒的人。

慢性病患者先确认运动边界。糖尿病患者外出可带随身糖类食品，并按医嘱处理低血糖风险。心脏病患者运动方案请遵医嘱。

可以把运动分散到一天中。早上走一小段，下午做几次坐站，晚上练习脚踝活动。每次不必很久。规律活动比偶尔一次过量运动更安全。

例如，陈爷爷曾在小区散步时差点摔倒。他改穿防滑鞋，选择平坦路线，并请邻居陪走。康复人员还教他扶桌练习起立。几周后，他走路更安心。

运动后留意疼痛和疲劳。轻微肌肉酸可能会出现，但持续加重的疼痛不宜忽视。有关节置换、骨折或心脏病的人，先确认适合动作。每个人恢复速度不同。

活动前先检查身体状态。前一晚没睡好、天气闷热或刚发烧时，可以降低活动量。运动时带手机，告诉家人准备去哪里。独居者可以约好出门和回家的报平安时间。

室内练习要选择稳固椅子。椅子靠墙，地面不滑。起立时双脚分开，身体稍向前，再用腿部力量站起。坐下时慢慢后退，感觉椅面在身后再坐。

康复有时进展不均匀。今天做得多，明天可能疲劳。允许自己休息，并把变化告诉康复人员。若出现新发麻木、胸痛或严重呼吸困难，停止训练并求助。

平衡练习前先保证旁边有支撑物。闭眼、单脚站立或在不平地面练习，跌倒风险较高，不适合独自尝试。选择稳固椅子和家人陪同，先练基本动作。

如果活动后出现关节肿胀或疼痛持续到第二天，下一次减少动作次数。短暂休息后仍不改善，咨询康复人员。运动计划可以调整，不必因为中断几天就放弃。

术后复诊时带上康复记录。告诉医生哪些动作做得到，哪些动作会痛。康复目标应能融入穿衣、洗澡、做饭和出门等生活任务。

户外活动最好结伴。告知家人路线和预计返回时间。天气不好时可以在家走动、做伸展。每次活动后检查鞋袜和皮肤，尤其是糖尿病患者的脚。

本章小结

- 从少量、轻松的活动开始，慢慢增加。
- 力量和平衡练习要有支撑，避免独自挑战。
- 术后康复按出院计划，不照搬他人经验。

- 胸痛、头晕、气喘明显时立刻停止。

☑ 自测题

1. 运动时出现胸痛，怎么办？ A.坚持完成 B.停下休息并按情况求助 C.加快速度

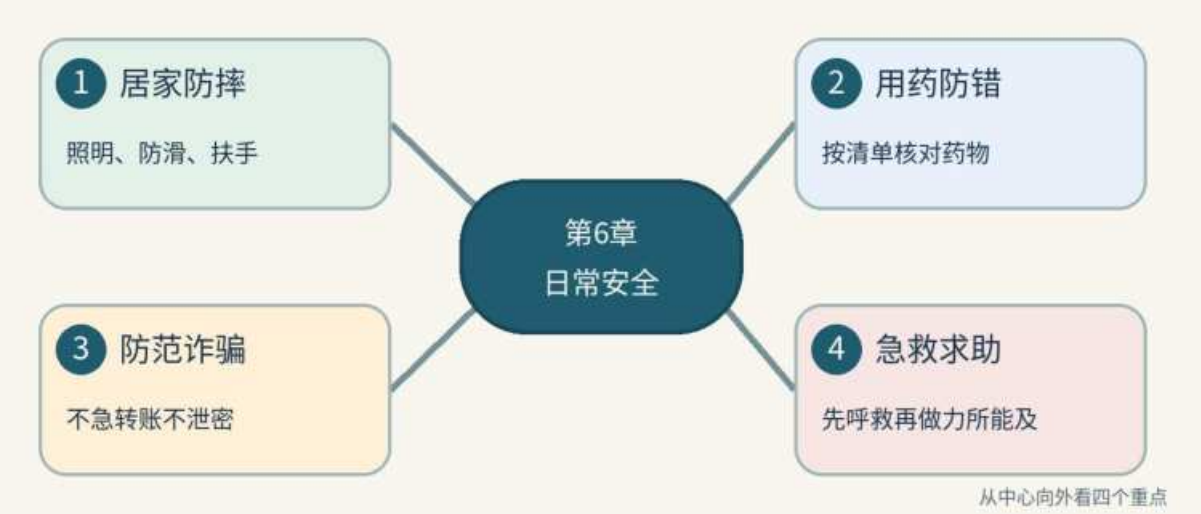
2. 术后活动安排应依据什么？ A.邻居经验 B.网络短视频 C.出院指导和医生建议

答案：1.B 2.C

♥ 生活小贴士

- 今天扶着稳固桌面练习几次坐站。
- 检查家中夜间通道是否有灯。

第六章 日常生活安全——居家防跌倒、用药安全、防诈骗、急救常识



第 6 章导图：日常安全的四个重点

6.1 居家环境：把容易绊人的地方清掉

家里是最熟悉的地方，也可能藏着绊脚物。走道和床边不要堆箱子、电线。地毯固定好。浴室放防滑垫，安装牢固扶手。

常用物品放在胸口到腰部高度。不要站在椅子上取高处物品。夜灯放在卧室到厕所的路上。楼梯边要有牢固扶手。

洗澡时水温不要太烫。进出浴缸或淋浴间慢一些。容易头晕的人可以坐着洗澡。家中老人常跌倒，建议医生检查药物、视力和平衡。

跌倒后若头部撞击、髋部剧痛、无法站起或意识改变，不要急着扶起来。呼叫急救或请专业人员评估。

6.2 用药安全和外出安全

药物放在干燥、儿童碰不到的地方。不要把药放进饮料瓶。保留原包装和说明。定期检查有效期。

外出带药时，用原包装或清楚标记的药盒。随身携带疾病和紧急联系人卡片。长途旅行前，请医生确认药量和保存办法。

戴合适眼镜，走路不看手机。过马路时留意信号灯和转弯车辆。雨天选择防滑鞋。天黑后尽量有人同行。

药物可能引起困倦或头晕。新加药后注意身体反应。若发生摔倒或近乎摔倒，告诉医生。

6.3 防诈骗：不给陌生人转账

陌生电话说您涉案、中奖、欠费，先挂断。公检法不会让您把钱转到“安全账户”。银行也不会索要密码和验证码。

遇到自称医生的人卖药，不因免费体检就交钱。亲友突然借钱，也先用熟悉号码回拨。不要点陌生短信里的链接。

个人身份证、银行卡、手机验证码都很重要。不要拍照发给陌生人。家人可以约定一个只有家人知道的核实暗号。

若已经转账，尽快联系银行止付，并报警。保留电话、聊天、转账凭证。越早处理，越有机会减少损失。

6.4 急救常识：呼救、心肺复苏和出血处理

遇到急症先确认现场安全。叫患者名字，轻拍肩膀。若无反应，呼叫周围人帮忙，并拨打 120。请一人取附近的自动体外除颤器。若患者没有正常呼吸，立即开始胸外按压。让患者仰卧在坚硬平面。双手叠放在胸口中央。手臂伸直，用身体重量向下压。按压深度约 5 至 6 厘米，速度每分钟 100 至 120 次。每次按压后让胸部回弹。尽量减少停顿。若会人工呼吸，可按 30 次按压、2 次吹气进行。不会吹气时，持续按压也有帮助。

自动体外除颤器到达后，打开并按语音提示操作。电击时确保无人接触患者。继续按压，直到患者恢复正常呼吸或急救人员接手。

伤口出血时，用干净纱布持续按压。不要反复掀开查看。疑似骨折时减少搬动。烫伤用流动凉水降温，不涂牙膏或酱油。



图 6-1 心肺复苏培训器材。实际操作请听从急救调度员指导。

每月可以和家人一起走一遍家中通道。检查地毯、电线、浴室地面和床边灯。发现问题就当天处理。小改变往往比提醒老人“走慢点”更有效。

比如浴室没有扶手，家人可请专业人员安装牢固扶手。毛巾架不能当扶手使用。地垫若容易滑动，就更换防滑款或移除。常用物品放低，减少登高取物。

家中准备一个急救信息袋。里面放疾病清单、药物清单、过敏信息和联系人。外出就诊时带上。突发情况中，清楚资料能帮助急救人员更快了解患者。

如果有人突然晕倒，先看周围有没有电线、火源或车辆危险。确认安全后再靠近。不要摇晃颈部受伤者，也不要把昏迷的人扶坐起来。拨打急救电话时，说清地点、楼栋和明显地标。

家中可备常用急救物品，如纱布、绷带、手套和手电筒。定期查看有效期和电池。急救用品要放在固定位置，让家人都知道在哪里。

急救现场不要围观拍摄，也不要随意移动患者。留出空间让急救人员工作。拨打 120 时开免提，按调度员提问回答。可以安排一人在楼下接车。

家中老人若独居，可佩戴紧急呼叫设备或设置简易报平安机制。每天固定时间给亲友发消息。门锁和地址信息也要让可信任的家人知道。

防诈骗宣传中，记住“慢一步”。任何要求保密、立刻付款或下载陌生软件的说法，都先停下来。独自拿不准时，找两位熟悉的家人核实。

家中照明开关要容易够到。床边放稳固拖鞋或防滑鞋。老人起夜时先坐在床沿，再站起来。若常有头晕，起身动作放慢，并向医生说明。

本章小结

- 地面清爽、灯光够亮、扶手牢固，能减少跌倒。
- 陌生来电要求转账或验证码，先挂断核实。
- 无反应且无正常呼吸，拨 120 并尽快按压。
- 急救时先保证现场安全。

自测题

1. 胸外按压的速度约为？ A.每分钟 100 至 120 次 B.每分钟 20 次 C.随意

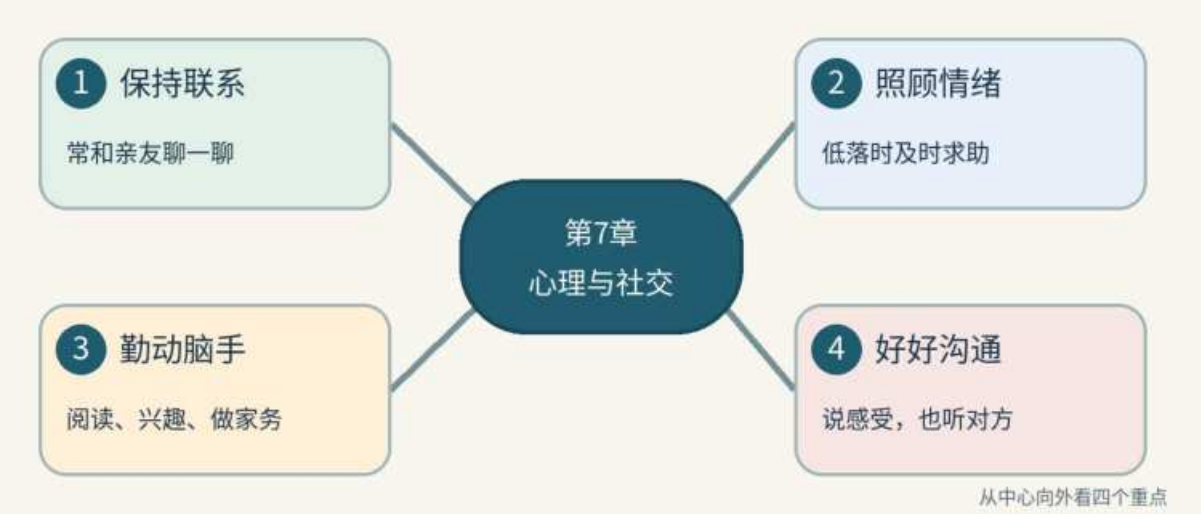
2. 陌生电话要求转入安全账户，怎么办？ A.立即转账 B.挂断并用官方号码核实 C.告诉对方验证码

答案：1.A 2.B

生活小贴士

- 清理床边和走道的一处绊脚物。
- 和家人约定陌生借钱电话的核实办法。

第七章 心理健康与社交——孤独感应对、认知衰退预防、家庭沟通



第 7 章导图：心理与社交的四个重点

7.1 情绪变化值得被看见

退休、搬家、丧偶或身体不适，都可能让人心情低落。偶尔难过是正常反应。可以和信任的人说说，给自己一点时间。

若低落持续两周以上，兴趣明显减少，睡眠或食欲大变，或总觉得自己没用，可以向医生求助。抑郁不是“想开点”就能解决的事。

每天给生活留一个小目标。比如晒太阳、浇花、做一顿饭。完成后记下来。规律起床、适当活动和与人交谈，都有帮助。

若出现伤害自己的想法，别一个人扛着。马上告诉家人或医生，并寻求急救支持。

7.2 孤独感：建立稳定联系

孤独不一定是身边没人。有时身边有人，却觉得没人理解。可以从每周固定联系一位亲友开始。一次电话、一次散步，都能让关系继续生长。

参加社区活动、兴趣小组或志愿服务，可以认识新朋友。选择自己喜欢的活动，不必勉强参加太多。线上聊天也可补充联系，但要保护个人信息。

如果听力不好，聊天会更费力。可以先检查听力，选择安静环境面对面交流。请对方慢一点说，不必觉得不好意思。

家人探望时，可以一起做事。比如买菜、看照片、做饭。陪伴不一定要讲大道理，认真听就很有用。



图 7-1 老友下棋交流。社交活动可按兴趣和体力选择。

7.3 保护记忆和思考能力

大脑也喜欢规律生活。睡眠、活动、均衡饮食和社交都有帮助。读报、下棋、学新歌，可以让大脑保持参与。没有一种练习能保证不患痴呆。

血压、血糖和听力问题要及时管理。长期独处、睡眠差、情绪低落，也可能影响记忆。突然糊涂还可能是感染、药物或其他急病，需要尽快评估。

把钥匙放在固定盒子里。重要事情写在日历上。药物用分格药盒，并请家人定期核对。生活工具是帮手，不代表能力变差。

若记忆变化影响用火、服药、财务或出行安全，尽早看医生。家人可记录具体情况，帮助医生判断。

7.4 家庭沟通：商量着安排照护

谈健康时，先问老人最担心什么。不要一开口就批评或替人做主。可以说：“我们一起看看哪种办法更方便。”

照护计划包括看病陪同、家务、运动和紧急联系人。把任务分给家人，避免一个人长期承担。定期商量计划是否需要调整。

老人也可以主动表达偏好。比如希望谁陪诊，哪些事想自己做。提前讨论授权、财务和照护意愿，能减少紧急时的慌乱。

意见不同时，先把事实和感受分开。若争执影响照护，可请医生、社区工作人员或社会工作者一起沟通。

安排社交不必很复杂。可以每周固定一天和朋友散步，或和家人一起吃饭。喜欢安静的人，也可以先从短时间联系开始。让活动符合自己的体力和兴趣。

例如，周阿姨丈夫去世后很少出门。女儿先陪她去社区花园坐坐，后来她加入了合唱小组。她仍会想念丈夫，但生活里多了一些熟悉的人。

照护者也需要休息。长期照顾家人容易疲惫和内疚。家庭可以轮流陪诊、做饭和处理事务。需要时向社区或专业机构询问照护支持。

保护大脑也包括保护身体安全。戴好眼镜和助听器，减少因为看不清、听不清而少出门。规律睡觉和吃饭，让一天有熟悉的节奏。

家中谈话时减少电视背景声。一次只说一件事，给老人足够时间回应。遇到记忆错误，不必当面争辩。先安抚情绪，再一起查看日历或记录。

如果出现突然混乱、嗜睡或性格明显改变，要及时就医。尤其是伴随发热、摔倒、尿痛或新用药时。急性变化可能与身体疾病有关，不要简单归咎于年龄。

社交活动要循序渐进。刚开始可以只参加半小时，觉得累就回家。选择交通方便、环境安全的地点。家人陪同一次，帮助确认路线和卫生间位置。

兴趣不一定要花钱。可以在家听音乐、养花、读书或做手工。与人分享作品或心得，也是一种交流。重要的是有期待、有参与，不必追求活动数量。

发现亲友情绪异常，可以直接、温和地询问：“你最近是不是很难受？”认真听，不急着讲道理。若有自伤风险，陪伴并尽快联系专业帮助。

可把家人合照、日历和提醒卡放在常看的地方。对认知变化者，熟悉的物品能帮助安心。不要用羞辱或威胁的方式纠正错误，重点是减少危险并维持尊严。

本章小结

- 情绪困扰可以求助，不必独自忍耐。
- 固定联系、共同活动，能减少孤独。
- 管理慢病、睡眠和听力，也是在照顾大脑。
- 家庭照护多商量、分任务、常复盘。

☑ 自测题

1. 情绪低落持续且影响生活，怎么办？ A.责怪自己 B.向医生或可信任的人求助 C.完全不说

2. 发现家人记忆明显变差，最好怎么做？ A.记录具体例子并就医 B.责骂提醒 C.自行买药

答案：1.B 2.A

♥ 生活小贴士

- 今天主动联系一位亲友。
- 把最近的记忆或情绪变化告诉家人。

第八章 定期体检与就医指南——体检项目怎么选、看病流程、医保使用



第 8 章导图：体检与就医的四个重点

8.1 体检项目：按年龄和风险来选

体检像给身体做一次盘点。不是项目越多越好。先了解自己的年龄、疾病、家族史和上次结果，再和医生商量。

常见基础项目包括问诊、身高体重、血压、血常规、尿常规、血糖和血脂等。是否需要心电图、影像或肿瘤筛查，要看个人风险。

抽血项目可能要求空腹。体检前先问清楚。正在吃的药不要随意停。需要空腹服用的药或胰岛素，请提前询问医护人员。

检查结果出现箭头，不等于一定有病。要结合症状、既往结果和医生判断。保留历年报告，复查时更容易看出趋势。

8.2 65 岁以上老年人健康管理

国家基本公共卫生服务为辖区内 65 岁及以上居民提供老年健康管理。服务内容和安排可向社区卫生服务中心咨询。不同地区的具体流程可能不同。

体检前准备好身份证、医保凭证、药物清单和既往报告。提前写下最想问的三件事。比如头晕、夜尿或药物副作用。

体检后拿到结果，要看医生的解释和后续建议。异常指标可能需要复查。不要只看手机上的箭头，也别自行购买“调理产品”。

如果行动不便，可以问社区是否有预约、陪诊或上门服务。家属可以协助预约，但就诊时让老人自己表达感受。

8.3 看病流程：把问题讲清楚

预约前确认医院科室和时间。带好证件、医保凭证、检查报告和药物清单。按医院要求取号或报到。

见到医生时，可以按“什么时候开始、哪里不舒服、怎样变化、吃过什么药”来讲。按时间顺序说明，医生更容易了解情况。

离开前确认诊断、药物用法、复查时间和危险信号。没听懂时请医生再说一遍。可以把重点写下来，避免回家忘记。

急症不要等待普通预约。胸痛、呼吸困难、疑似脑卒中或严重外伤，拨打 120。不要因担心费用而延误急救。



图 8-1 老人向医疗服务人员咨询就诊信息。

8.4 医保使用和就医准备

医保政策会因地区、参保类型和年度而不同。门诊统筹、慢特病待遇、异地就医备案等事项，请以当地医保部门最新规定为准。

就医前可通过官方医保服务平台、当地医保热线或医院窗口查询。确认医院是否联网结算。异地就医者提前问清备案和报销材料。

保存收费票据、费用清单和处方。办理转诊或报销时，按当地要求准备资料。不要把医保卡交给他人代刷，也别出租、出借医保凭证。

需要长期用药时，可以询问医生是否适合长期处方或基层续方。定期核对药物，避免重复开药。医保报销范围请向当地经办机构确认。

体检后可以把报告分成三类：正常且稳定、需要观察、需要尽快复查。请医生帮助分类，不要自己猜。把复查日期记进日历，并在检查前确认准备事项。

例如，赵先生看到血脂偏高，就自己买了多种保健品。他后来带报告就诊，医生先询问饮食、药物和既往病史，再决定是否治疗。单个箭头不能直接决定吃药。

就诊问题可以提前写在纸上。药物是否继续、结果要不要复查、何时再看医生，都是常见问题。若听力或记忆不便，可请家人陪同，并在离开诊室前复述医嘱。

就诊时最好有人陪同，但要让老人先说自己的症状。家属可以补充时间、用药和生活变化。若医生提出检查或治疗，可以询问目的、好处、风险和替代办法。

复诊前核对预约时间和检查准备。需要空腹时，问清楚能否照常吃药。糖尿病患者尤其要确认降糖药和进食安排，避免低血糖。不要自己停掉长期用药。

医保报销与医疗救助政策可能调整。遇到不确定事项，使用政府官方平台或拨打当地医保服务热线。不要把身份证照片、验证码发给声称代办报销的陌生人。

报告上某项结果偏离范围时，先确认单位、参考范围和检查条件。不同医院设备和方法可能略有差异。医生会判断是否需要复查或进一步检查。

体检不是替代平时看病。出现持续症状，即使上次体检正常，也要就医。体检报告也不能单独用于自行开药或停药。

可把报告按年份装订，第一页写上疾病和手术史。复诊时先告诉医生近期最困扰的问题，再逐项讨论报告。时间有限时，这样不容易漏掉重点。

本章小结

- 体检项目要结合个人风险，不追求越多越好。
- 带齐报告和用药清单，按顺序讲清症状。
- 检查异常要让医生解释，不自行对号入座。
- 医保规则看当地最新政策。

☑ 自测题

1. 体检前可以怎样准备？ A.带药物清单和旧报告 B.自行停药 C.不说既往病史

2. 异地就医医保政策应向哪里核实？ A.陌生推销电话 B.当地医保部门或官方平台 C.网络广告

答案：1.A 2.B

♥ 生活小贴士

- 整理最近一次体检报告和药物清单。
- 写下下次就诊最想问医生的三件事。

资料依据与使用说明

本教材编写时参考下列公开资料。指南可能更新，读者就诊时请以医疗机构和主管部门最新信息为准。

1. 国家卫生健康委：成人健康体检项目推荐指引（2025 年版）
https://www.nhc.gov.cn/yzygj/c100068/202511/4feaeb6de63e44cb9fd4ac8f579ca279.shtml

2. 中国高血压防治指南（2024 年修订版）
https://cjournal.hep.com.cn/1673-7245/CN/1160171857581368285

3. 国家卫生健康委：全国高血压日宣传材料
https://www.nhc.gov.cn/ylyjs/gzdt/202409/bfc23c5086044eb0b4879e58e4df69e1.shtml

4. 中国居民膳食指南（2022）：规律进餐，足量饮水
https://dg.cnsoc.org/article/04/wDCyy7cWSJCN6pwKHOo5Dw.html

5. 国家卫生健康委：老年人健康管理服务
https://www.nhc.gov.cn/jws/qta/201408/99c67d0a488747b6948a04b960e7895b.shtml

6. 国家应急广播：公众心肺复苏和自动体外除颤器使用科普
https://www.cneb.gov.cn/kepuku/shenghuoanquan/jujiaanquan/jinjijiuhu/

说明：本教材用于健康教育，不提供个体诊断。具体药物、饮食、饮水、运动和康复方案，请结合病情咨询医生、药师或营养专业人员。